

Referencia, traslado seguro y continuidad

Procedimiento | Alcance base: fisioterapia | Estado: propuesta para adopción

1. Objetivo y resultado esperado

Comunicar necesidad de atención adicional y asegurar transición clínica según estabilidad y riesgo.

2. Alcance y condiciones de uso

Remisiones ordinarias, prioritarias y urgentes; no convierte al consultorio en servicio de transporte o urgencias.

3. Responsabilidades por rol

Rol	Responsabilidad
Fisioterapeuta	Identificar necesidad y urgencia y realizar entrega clínica.
Apoyo real	Gestionar comunicación y documentos sin alterar la decisión clínica.
Responsable de continuidad	Confirmar directorio, recepción y seguimiento posible.

4. Recursos y preparación

Mantener documento vigente, responsables reales, recursos de la actividad y soportes del emisor o fabricante pertinentes. Antes de ejecutar comprobar disponibilidad y seguridad; si falta un recurso crítico, controlar el riesgo y registrar suspensión o alternativa.

Secuencia operativa y decisiones

El orden se adapta al episodio sin omitir los controles de seguridad. Las técnicas y parámetros concretos se definen por competencia, evidencia y fabricante; no se completan con valores de ejemplo.

1. Identificar motivo, urgencia y condición clínica

Identificar motivo, urgencia y condición clínica. Suspender actividad insegura y realizar soporte dentro de competencia cuando la persona requiere atención inmediata.

2. Explicar al paciente y acompañante autorizado motivo, destino y riesgos, sin esperar autor

Explicar al paciente y acompañante autorizado motivo, destino y riesgos, sin esperar autorización administrativa para gestionar urgencia. Registrar decisión y límites de la información disponible.

3. Verificar recurso receptor y medio de traslado adecuados al estado

Verificar recurso receptor y medio de traslado adecuados al estado. Persona inestable requiere respuesta asistencial pertinente; no se envía sola por transporte no asistencial.

4. Preparar referencia, resumen de historia y apoyos diagnósticos disponibles, incluyendo tie

Preparar referencia, resumen de historia y apoyos diagnósticos disponibles, incluyendo tiempos, antecedentes, evaluación, acciones y parámetros relevantes. Proteger datos en medio de envío.

5. Comunicar al receptor y registrar contacto, hora, recurso solicitado y resultado

Comunicar al receptor y registrar contacto, hora, recurso solicitado y resultado. Si no hay respuesta, activar alternativa y mantener vigilancia según competencia, sin prometer un tiempo de ambulancia.

6. Documentar salida, receptor y seguimiento posible; registrar barreras y acciones

Documentar salida, receptor y seguimiento posible; registrar barreras y acciones. Incorporar contrarreferencia cuando llega para ajustar plan o definir egreso.

Control, frecuencia y corrección

5. Verificación de la ejecución

Prioridad por estado clínico.

Resumen y envío protegido.

Registro de barreras y destino.

Momento	Comprobación y conducta
Antes	Verificar alcance, recurso y condición de uso descritos. Resolver discrepancias antes de comenzar; documentar aplazamiento cuando no es seguro.
Durante	Seguir los pasos de este documento y registrar modificaciones, novedades y actuaciones reales. Detener ante los criterios de riesgo del proceso.
Después	Comprobar resultado, integridad, limpieza o continuidad según proceso. Vincular registro y autor, sin dar por cumplida una tarea no observada.
Ante hallazgo	Contener el riesgo, describir causa, asignar acción y comprobar eficacia. Mantener abierto el pendiente mientras no exista evidencia de cierre.

6. Registro, conservación y seguimiento

Utilizar la ficha o formato asociado y conservar fecha, episodio, ejecutor y soporte. Los registros clínicos se incorporan a la historia reservada; documentos laborales y administrativos tienen acceso según su finalidad. Reproducir páginas de registro cuando se necesita espacio, sin condensar la información clínica ni registrar valores supuestos.

7. Aplicación normativa específica

11.1.7 y 11.3.1.29-30: para terapias el criterio específico indica no aplica. Se conserva referencia, emergencia y continuidad del 11.1.5.17; no imponer contratos de red universales.

8. Adopción y revisión

Completar responsables y condiciones de sede, leer referencias y manuales íntegros, validar el proceso y socializarlo. Registrar versión adoptada y autenticación; revisar ante cambio de norma, producto, equipo, técnica o hallazgo y en el ciclo local anual. Frecuencias y metas locales de esta edición no se presentan como exigencias legales universales.

Ficha de aplicación y referencias

Registro vacío para reproducir. Completar solo con hechos reales; identificar el documento o expediente al que pertenece. No incluye nombre, logo ni firmas preincorporadas.

Paciente y fecha hora	
Motivo y prioridad	
Estado y alarmas	
Acciones y respuesta	
Destino y contacto	
Medio de traslado	
Documentos enviados	
Información y decisión	
Receptor y tiempo	
Continuidad	

Fuentes y límites

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes; manual, criterios generales 11.1 y servicio de terapias 11.3.1. Resolución 2080 de 2026, artículo 1: revocatoria integral de 1732 de 2026; no se utiliza su manual como exigencia vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Historia clínica

Resolución 1995 de 1999, artículos 3-5 y 11-14: registro, autoría, anexos, custodia y acceso. Resolución 839 de 2017, artículo 3: retención general mínima de 15 años y reglas especiales; el archivo no se elimina automáticamente al vencer un plazo.

<https://minsalud.gov.co/ihce/Paginas/Normatividad.aspx>

Prácticas seguras

Resolución 3100, 11.1.5: política, actividades, instancia proporcional, identificación, comunicación, infección, eventos y consentimiento, documentación y formación; aplicar los criterios pertinentes al servicio.

<https://www.minsalud.gov.co/salud/prestacion-servicios/Paginas/sistema-obligatorio-garantia-calidad.aspx>

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576